

Plausibilitätsprüfungen

A-Plausibilitätsprüfungen

01_A_SEX_fehlerhaft

Alle Fälle aus der Union-Tabelle Ebene 4¹, bei denen keine Angabe zum Geschlecht oder ungültige Ausprägungen vorhanden sind.

37_A_Mehrfachmeldung

Alle Fälle aus der Union-Tabelle Ebene 4, bei denen TUMID = NULL, d.h. diese Fälle haben bei der Prüfung auf Mehrfachmeldungen zu einem Tumor keine Tumor-ID² zugewiesen bekommen, wurden also gelöscht.

54_A_ICD10_keineAuswertung

Alle Fälle aus der Union-Tabelle Ebene 4, bei denen ICDGM10 = NULL, d.h. diese Fälle haben bei der Neukodierung keinen ICD10-Kode zugewiesen bekommen. Dies kann z.B. daran liegen, dass die ursprünglich gelieferten Angaben fehlerhaft waren und nicht übersetzt werden konnten oder dass der ICD10-Kode außerhalb des vom ZfKD verwertbaren Bereichs (C00-C76, C80-C97, D00-D09, D32-D33 oder D37-D48) lag.

58_A_Zeitangaben_fehlerhaft

Alle Fälle aus der Union-Tabelle Ebene 4, für die die Datumsangaben nicht logisch sind bzw. der Fall bei fehlenden Angaben nicht verwertet werden kann, d.h.:

- das Diagnosedatum ist NULL oder
- das Geburtsdatum ist NULL oder
- das Geburtsdatum liegt nach dem Sterbedatum oder
- das Diagnosedatum liegt nach dem Sterbedatum oder
- das Geburtsdatum liegt nach dem Diagnosedatum

66_A_ICD10_SEX_fehlerhaft

Männer mit frauentypischen Tumoren (ICD10 = C51-C58) oder Frauen mit männertypischen Tumoren (ICD10 = C60-C63).

¹ intern liegen die Daten auf Ebene 4 nach allen technischen und inhaltlichen Umformungen vor. Auf Ebene 5 werden Fälle der A-Prüfungen ausgefiltert.

² die Tumor-ID kennzeichnet die errechnete Reihenfolge der Tumoren pro Person

B-Plausibilitätsprüfungen

12_B_TOD_Ja_Aber_Kein_SJ

Alle Fälle, bei denen der Patient angeblich verstorben ist (TOD = 1), aber kein Sterbedatum vorhanden ist. Die Fälle werden aus Survival Analysen ausgeschlossen.

20_B_TNMT_DIG_unplausibel

Alle Fälle, die keinen Paget-Tumor beschreiben (HISC nicht 8540 – 8543), aber Widersprüche in der Dignität und dem T-Stadium vorweisen (T-Stadium = in situ, Dignität = invasiv).

Anmerkung: bei Paget-Tumoren ist dieser Unterschied durchaus erlaubt

39_B_DCO_DDIMP_inkonsistent

Alle Fälle zum gleichen Patienten mit gleichem Diagnosedatum, bei denen sich die DCO-Angabe voneinander unterscheidet.

55_B_HISC_ICDO3_unplausibel

Alle Fälle, bei denen die Angaben zu Histologie und Lokalisation nicht plausibel erscheinen. Grundlage dafür ist die Tabelle [ZfKDMeta].[meta].[dtSiteHistology].

60_B_PatAngaben_inkonsistent

Die Angaben zu Geburts- oder Sterbedatum, zu Geschlecht oder Tod widersprechen sich in Meldungen ein und desselben Patienten.

67_B_DALT_HISC_ICD10_unplausibel (IARC-Test „Age/Site/Histology“)

Alle Fälle, bei denen die Kombination aus ICD10/Histologie und Diagnosealter nicht plausibel ist:

Alter	Histologie- oder ICD10-Kode
Alter unter 15 Jahre (Childhood Check)	
0 – 2	9650/3 – 9667/3 (Hodgkin-Lymphome)
10 – 14	9490/3, 9500/3, 9522/3 (Neuroblastome)
6 – 14	9510/3 – 9514/3 (Retinoblastome)
9 – 14	8960/3 (Nephroblastom oder Wilms-Tumor)
0 – 8	C64 (Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken)
6 – 14	8970/3 (Hepatoblastom)
0 – 8	C22 (Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge)
0 – 5	9180/3 – 9187/3 und 9192/3 – 9195/3 (Osteosarkome)
0 – 5	9220/3 – 9221/3, 9231/3, 9240/3, 9243/3 (Chondrosarkome)
0 – 3	9260/3 (Ewing-Sarkom)
8 – 14	9060 – 9102 und Lokalisation nicht C569, C620, C621, C629 (nicht den Gonaden entstammende Keimzelltumoren)
0 -14	Karzinome, die den Gonaden entstammen (8010 – 8041, 8050 – 8075, 8120 – 8122, 8130 – 8141, 8244 – 8246, 8260 – 8263, 8480 – 8490, 8560 – 8573, 8143, 8155, 8210, 8211, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430, 8440, 8504, 8510, 8550 und Lokalisation = C569, C620, C621, C629 und Dignität = 3)

0 – 5	C73 (Bösartige Neubildung der Schilddrüse)
0 – 5	C11 (Bösartige Neubildung des Nasopharynx)
0 – 4	C43 – C44 (Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut)
0 – 4	8010/3 – 8046/3 (Karzinome o.n.A.)
0 – 14	9050/3 – 9055/3 (Mesotheliome)
Alter über 15 Jahre	
15 – 39	Histologie = 814_ und Lokalisation = C61 (Adenokarzinome der Prostata)
15 – 19	Lokalisation = C15, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C50, C54, C55, C38.4
15 – 19	Histologie < 9590 und Lokalisation = C17 (solider Tumor des Dünndarms)
15 – 19	Histologie <> 824_ und Lokalisation = C18, C33, C34
> 45	Histologie = 9100 und Lokalisation = C58 (Chorionkarzinom der Plazenta)
15 – 25	9732, 9823
> 15	8910, 8960, 8961, 8962, 8970, 8981, 8991, 9072, 9470, 9687

69_B_DIG_ICDO3_unplausibel (IARC-Test „Behaviour/Site“)

Alle Fälle, bei denen die Kombination aus Lokalisation und Dignität nicht plausibel ist. Für folgende Lokalisationen ist die Dignität 2 (in-situ) nicht plausibel:

C40 - C41 (Knochen, Gelenke und Gelenkknorpel)

C42 (Hämatopoetisches und retikuloendotheliales System)

C47 (Periphere Nerven und autonomes Nervensystem)

C49 (Bindegewebe, Subkutangewebe und sonstige Weichteile)

C70 - C72 (Meningen, Gehirn, Rückenmark, Hirnnerven und sonstige Teile des Zentralnervensystems)

70_B_DIG_HISC_unplausibel (IARC-Test „Behaviour/Histology“)

Die Kombination aus Dignität und Histologie ist in der ICDO3 nicht vorgesehen.

Pathologen sind jedoch durchaus berechtigt, auch andere Kombinationen aus Histologie und Dignität zu vergeben. Daher wird hier lediglich darauf hingewiesen.

72_B_DSICH_HISC_unplausibel

Die meisten Diagnosen können nur durch eine mikroskopische Untersuchung gesichert werden. Für einige Histologien ist eine nicht-mikroskopische (DSICH = 1, 2, 4) Diagnosesicherung jedoch zulässig.

Fälle werden als nicht plausibel gekennzeichnet, wenn die folgenden Kombinationen aus Histologie und Diagnosesicherung auftreten:

Diagnosesicherung	Histologie NICHT...	Lokalisation	Dignität
1, 2, 4	8000, 8170, 8800, 8960, 9100, 9140, 9350, 9380, 9500, 9510, 9590, 9732, 9761, 9800, 8150 – 8154, 8270 – 8281, 9530 – 9539		

1, 2, 4	8720	C69, C44	
1, 2, 4	9384		1

76_B_TNMx_ICD10_unplausibel

Sind bei einer C-Diagnose (außer Brustkrebs „C50“) T = 0, N = 0 oder leer und M = 0 oder leer, dann widersprechen sich beide Angaben. Die Kombination aus der ICD10-Angabe und den Angaben zu den T-, N- und M-Stadien ist also nicht plausibel.

77_B_DALT_unplausibel

Unwahrscheinlich hohes Patientenalter, wenn der Patient bei Diagnose mindestens 115 Jahre alt war oder wenn der Patient heute mindestens 115 Jahre alt ist und noch lebt (TOD = 2).

78_B_TNMM_GROBST_unplausibel

M-Stadium = 0 (keine Metastase), aber Grobstadium = 4 (Metastase)

82_B_Entscheidung_Mehrfachtumor_unplausibel

Meldungen wurden als unterschiedliche Tumoren gekennzeichnet, obwohl die Histologien für einen einzelnen Tumor sprechen. Bedingung: HISC1 = 8140 und HISC2 beschreibt andere spezifischere Adenokarzinome (z.B. Leberkarzinome) aus Histologiegruppe 4.

85_B_GRAD_HISC_unplausibel (IARC-Test „Grade/Histology“)

Einige Histologiebegriffe wie z.B. „undifferenziertes malignes Teratom“ (9082/3) beinhalten eine Grading-Angabe. Diese Prüfung identifiziert diese histologischen Begriffe und überprüft, ob die Dignität dazu passt. Folgende Kombinationen sind nicht korrekt:

Dignität (DIG)	Grading oder Zelltyp (GRAD oder ZTYP)	Histologie	Beschreibung
0,1,2	Angaben zu GRAD vorhanden (1-4)		Nur bösartige Tumoren sollen ein Grading bekommen
	ZTYP = 5 - 8	< 9590	Nur Systemerkrankungen haben einen Zelltyp
	GRAD = 1 - 4	> 9590	Nur solide Tumoren haben ein Grading 1 - 4
	ZTYP <> 5	9702, 9705, 9706, 9708, 9709, 9717, 9718, 9729, 9827, 9834, 9837 (T-Zell-Lymphome)	Histologie beschreibt T-Zell-Lymphom, aber die Angabe zum Zelltyp nicht.
	ZTYP <> 5, 7	9714, 9831 (T-Zell- und Null-Zell-Lymphome)	Histologie beschreibt T-Zell- und Null-Zell-Lymphome, aber die Angabe zum Zelltyp nicht.
	ZTYP <> 5, 8, 9	9700, 9701, 9712, 9716, 9719 (T-Zell- und NK-Zell-Lymphome)	Histologie beschreibt T-Zell- und NK-Zell-Lymphome, aber die Angabe zum Zelltyp nicht.
	ZTYP <> 6	9670 – 9699, 9728, 9823,	Histologie beschreibt B-Zell-

		9826, 9833, 9836 (B-Zell-Lymphome)	Lymphome, aber die Angabe zum Zelltyp nicht.
	ZTYP <> 8	9948	Histologie beschreibt „Aggressive NK-Zell-Leukämie“ aber Zelltyp nicht.
	GRAD <> 1	8331, 9187, 9511	Histologie beschreibt gut differenzierte Karzinome, aber Grading nicht.
	GRAD <> 2	8332, 8858, 9083, 9243, 9372	Histologie beschreibt mäßig differenzierte Karzinome, aber Grading nicht.
	GRAD <> 4	8020, 8021, 8805, 9062, 9082, 9390, 9392, 9401, 9451, 9505, 9512	Histologie beschreibt undifferenzierte Karzinome, aber Grading nicht.
	GRAD <> 3	8631, 8634	Histologie beschreibt schlecht differenzierte Karzinome, aber Grading nicht.

C-Plausibilitätsprüfungen

14_C_SJ>MaxJahr

Bei allen Fällen, bei denen das Sterbejahr *nach* dem aktuellen Maximaljahr (2 Jahre vor Lieferjahr) liegt, werden die Sterbeangaben zensiert, so diese Informationen bezogen auf das aktuelle Maximaljahr „aus der Zukunft“ stammen. Die Variable TOD wird auf 2 gesetzt, die Variablen SJ, SM, SDIMP, TOD, TODTUM, ICDT10, ICDTAUFL, AUT werden auf NULL gesetzt.

43_C_DJ_korrigiert_aufgrund_DSICH

Alle Fälle, bei denen das Diagnosejahr korrigiert wurde.

Das Diagnosedatum wurde gleich dem Sterbedatum gesetzt, wenn die Angabe zur Diagnosesicherung nicht leer oder ungültig war oder durch eine Autopsie erfolgte und wenn das Diagnosedatum nach dem Sterbedatum lag. (DSICH <> 0 oder DSICH <> -999 und DDIMP > SDIMP)

Außerdem erfolgte eine Korrektur, wenn das Sterbejahr ungleich dem Diagnosejahr war und die Diagnose nur klinisch ohne spez. Diagnostik gesichert wurde (DSICH = 1 und SJ <> DJ).

44_C_TNMx_korrigiert

Alle Fälle, deren Ausprägungen zu T, N oder/und M nicht zur Lokalisation (Auflage 6 oder 7) passen, werden korrigiert.

Z.B. Prostata (C61): Wird die für diese Lokalisation nicht zulässige Ausprägung ‚T4a‘ von einem EKR geliefert, wird sie auf T4 gesetzt.

52_C_ICDO3_korrigiert

Alle Fälle, bei denen die ursprüngliche Angabe zur Lokalisation (ICDO3) durch die Neukodierung inhaltlich verändert wurde. Die ursprüngliche Variable darf dabei aber nicht leer gewesen sein, da dies keine wirkliche Veränderung aufzeigt.

56_C_HISC_korrigiert

Alle Fälle, bei denen die ursprüngliche Angabe zur Histologie durch die Neukodierung inhaltlich verändert wurde. Die ursprüngliche Variable darf dabei aber nicht leer gewesen sein, da dies keine wirkliche Veränderung aufzeigt.

64_C_DIG_korrigiert

Alle Fälle, bei denen die ursprüngliche Angabe zur Dignität durch die Neukodierung inhaltlich verändert wurde. Die ursprüngliche Variable darf dabei aber nicht leer gewesen sein, da dies keine wirkliche Veränderung aufzeigt.

74_C_TOD=1_korrigiert_aufgrund_Sterbeangaben

Laut Sterbeangaben (AUT, DSICH, SD, ICDT) ist der Patient verstorben, ist aber als lebend gekennzeichnet (TOD = 2). Die Variable „Tod“ wird dann auf TOD = 1 (verstorben) gesetzt.

80_C_ICD10DREI_korrigiert

Alle Fälle, bei denen die ursprüngliche Angabe zum ICD10-Dreisteller durch die Neukodierung inhaltlich verändert wurde. Für Fälle mit ICD10 = C22-C24, C38, C43-45 wird auch eine Veränderung der 4. Stelle dokumentiert.

84_C_LOKS_korrigiert

Der Test ist hervorgegangen aus 79_B_ICDO3_LOKS_unplausibel

Die Lokalisation und die Seitenangabe passen nicht zusammen, d.h. es handelt sich um ein paariges Organ, aber es wurde LOKS =4 angegeben. Die Information, ob ein Organ als paarig gesehen wird oder nicht, findet man in der Metatabelle.

Beschreibung
Angabe zur Seitenlokalisierung des Tumors (1-stellig):
1 = links
2 = rechts
3 = beidseitig
4 = trifft nicht zu
5 = mittig